

Resumo

Esta pesquisa reúne dados oficiais e estudos científicos para dimensionar o problema da doação de sangue no Brasil e fundamentar o projeto Sangue Solidário. A proposta não parte da afirmação de que os hemocentros não possuam sistemas próprios; o foco é identificar barreiras mensuráveis entre o cidadão e a realização da doação, como baixa participação, desconhecimento dos locais, deslocamento, tempo, medo e dificuldade de comunicação.

Em 2025, aproximadamente 1,5% da população brasileira doou sangue pelo SUS, com 3.264.138 coletas. A Anvisa também registra uma ampla rede de serviços de hemoterapia. Estudos brasileiros mostram que uma parcela expressiva de pessoas que ainda não doaram manifesta intenção de fazê-lo, mas encontra barreiras práticas ou informacionais. Esses dados sustentam a investigação de uma plataforma que centralize informações, campanhas, localização e, quando houver integração, recursos de agendamento.

1. Contextualização

A doação de sangue é um processo contínuo. O sangue coletado é separado em hemocomponentes com diferentes períodos de armazenamento, de modo que a manutenção do estoque depende de novas doações ao longo do tempo. O Ministério da Saúde informa que a rede pública realiza milhões de coletas e mantém ações permanentes de mobilização.

O Sangue Solidário foi pensado como uma camada complementar às estruturas existentes: em vez de substituir hemocentros, a plataforma pode facilitar o caminho do cidadão até eles.

2. Dados nacionais: tamanho do problema

Indicador	Dado	Fonte/ano
População que doou pelo SUS	≈ 1,5%	Ministério da Saúde / 2025
Doações por mil habitantes	15,29	Ministério da Saúde / 2025
Coletas de sangue	3.264.138	Ministério da Saúde / 2025
Serviços de hemoterapia	2.156	Anvisa / boletim nacional
Serviços públicos ou conveniados ao SUS	≈ 75%	Anvisa / boletim nacional
Coletas nos serviços de hemoterapia	≈ 3,3 milhões	Anvisa / boletim nacional
Hemocomponentes produzidos	≈ 8 milhões	Anvisa / boletim nacional

Fonte dos dados nacionais: Ministério da Saúde e Anvisa. A Anvisa alerta que seus dados brutos de produção podem conter inconsistências ou duplicidades; por isso, os números devem ser interpretados conforme a metodologia de cada base.

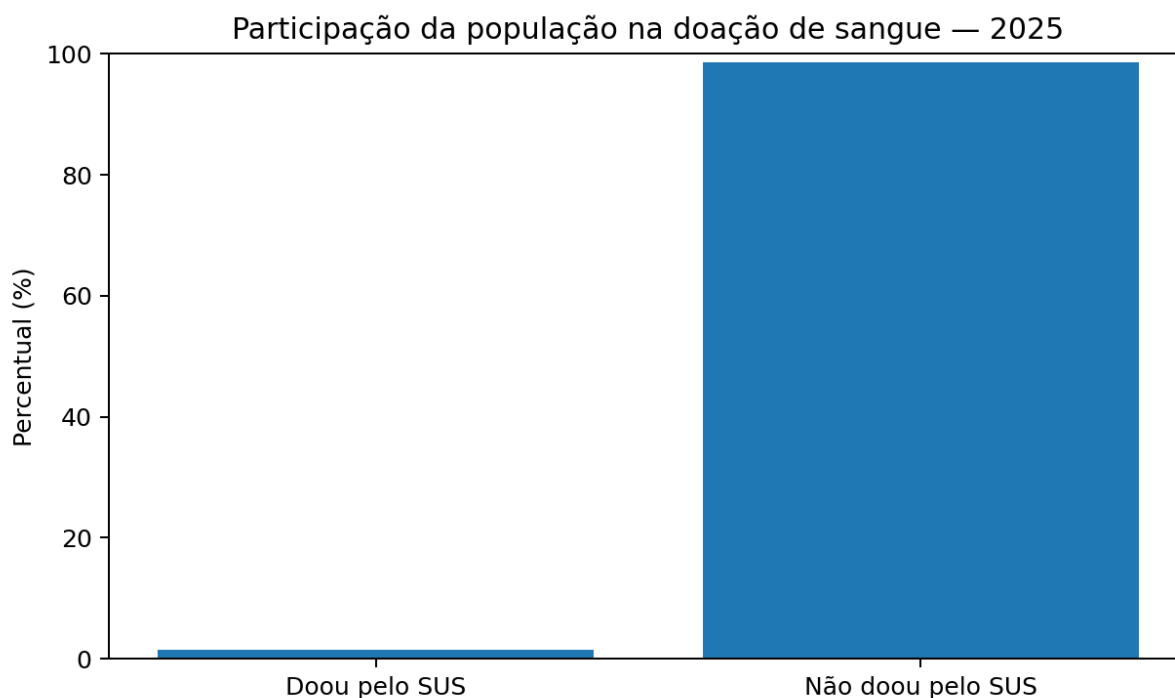


Gráfico 1 — Em 2025, cerca de 1,5% da população doou sangue pelo SUS. O percentual de 98,5% corresponde à parcela que não realizou doação pelo SUS no período; isso não significa que essas pessoas sejam necessariamente inelegíveis ou que nunca tenham doado por outras vias.

3. Rede de hemoterapia

A Anvisa informou 2.156 unidades de serviços de hemoterapia no país, aproximadamente 75% delas públicas ou conveniadas ao SUS. Esses estabelecimentos eram responsáveis por cerca de 3,3 milhões de coletas e aproximadamente 8 milhões de hemocomponentes no período do boletim.

A existência de uma rede extensa é relevante para o projeto porque aumenta a importância de informação de localização, horários, campanhas e comunicação. O desafio não é somente captar doadores, mas conectá-los de forma adequada aos serviços que realizam a coleta.

4. Barreiras quantitativamente identificadas

Um estudo brasileiro realizado com 1.055 usuários de unidades de atenção primária em Ribeirão Preto identificou 63,4% de participantes que nunca haviam doado sangue, 6,1% que haviam doado apenas uma vez e 17,2% que haviam doado múltiplas vezes. O estudo apontou medo de sangue, injeções e desmaio como barreiras e destacou a importância de informação sobre o processo.

Outro estudo, realizado com 527 doadores de um hemocentro público do Recife, encontrou 36,4% de participantes relatando dificuldade para chegar ao serviço e 50,3% de insatisfação com o tempo gasto na doação. Esses resultados são específicos das populações estudadas e não devem ser tratados como percentuais nacionais.

5. Intenção de doar e dificuldade de transformar intenção em ação

Um estudo transversal publicado em 2025 com 162 estudantes de Medicina encontrou 25,9% de participantes que já haviam doado e 74,1% que nunca haviam doado. Entre os não doadores, 81,7% declararam intenção de doar futuramente.

Entre as barreiras relatadas pelos não doadores, 26,7% indicaram desconhecimento dos locais de doação, 19,2% citaram medo de agulhas ou sangue e 15,0% citaram falta de tempo. Entre os canais de divulgação preferidos, Instagram apareceu com 82,7% e WhatsApp com 59,9%. Esses resultados pertencem à amostra estudada e servem como evidência de barreiras, não como estimativa da população brasileira inteira.

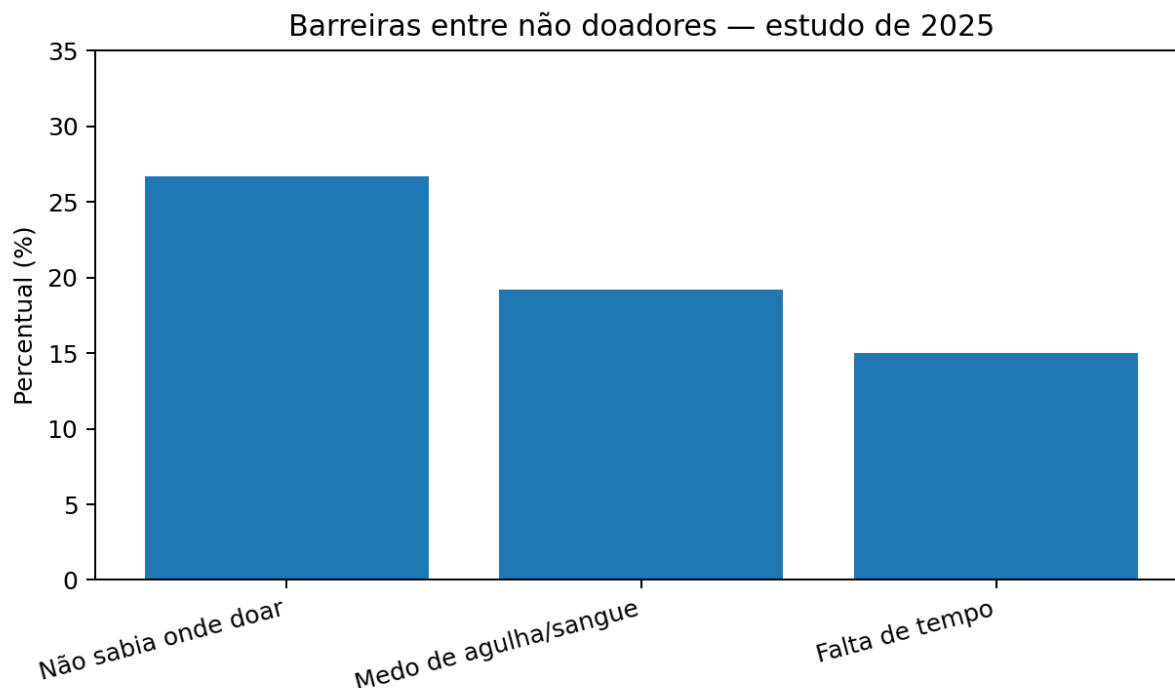


Gráfico 2 — Principais barreiras relatadas pelos não doadores no estudo de 2025.

6. Remanejamento de hemocomponentes

O Relatório de Gestão Integrado 2025 do Ministério da Saúde registra solicitações de remanejamento de concentrados de hemácias em situações de contingência. Em 2025 foram 3.352 solicitações e 3.157 atendimentos ($\approx 94,2\%$); em 2024 foram 6.969 solicitações e 4.947 atendimentos ($\approx 71,0\%$); em 2023 foram 10.340 solicitações e 5.145 atendimentos ($\approx 49,8\%$).

Esses números demonstram a existência de necessidade de coordenação e redistribuição de estoques em determinados períodos. Eles não significam que cada pedido não atendido corresponda automaticamente a uma falta absoluta de sangue, pois podem existir fatores operacionais.

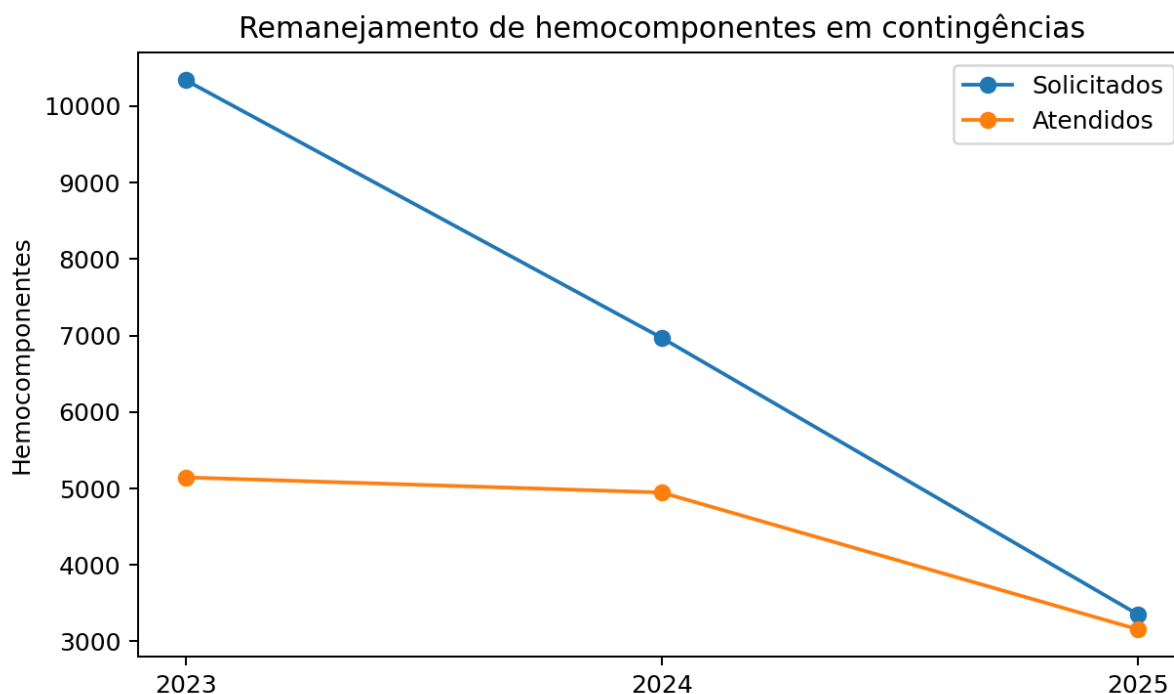


Gráfico 3 — Solicitações e atendimentos de remanejamento de hemocomponentes, 2023–2025.

7. O que os dados significam para o Sangue Solidário

Baixa participação relativa: Aproximadamente 1,5% da população doou pelo SUS em 2025. Isso evidencia a necessidade permanente de captação e fidelização.

Informação e localização: 26,7% dos não doadores do estudo de 2025 não sabiam onde doar. Uma plataforma pode centralizar locais e informações.

Acesso físico: 36,4% dos doadores estudados no Recife relataram dificuldade de chegar ao serviço. Mapas, endereços e orientações podem reduzir parte da fricção.

Tempo: 50,3% do estudo do Recife mostraram insatisfação com o tempo da doação; 15% dos não doadores do estudo de 2025 citaram falta de tempo.

Comunicação: Estudos e iniciativas brasileiras apontam comunicação e ferramentas digitais como caminhos para aproximar cidadãos dos serviços.

Intenção sem ação: 81,7% dos não doadores do estudo de 2025 pretendiam doar futuramente, mostrando uma oportunidade para estudar como reduzir barreiras entre intenção e comportamento.

8. Proposta de valor do projeto

Com base nos dados, o Sangue Solidário pode ser apresentado como uma plataforma complementar que busca tornar a jornada do doador mais simples. Entre as funcionalidades possíveis estão: busca de hemocentros por localização; informações sobre requisitos; divulgação de campanhas; horários e canais oficiais; lembretes; histórico de doações; e agendamento quando houver integração autorizada com o serviço.

É importante que o projeto seja apresentado como uma proposta de facilitação e comunicação, e não como substituição do trabalho dos hemocentros ou como garantia de aumento das doações. A efetividade da plataforma deverá ser avaliada por indicadores, como acessos, encaminhamentos para serviços, agendamentos concluídos e retorno de usuários.

9. Indicadores que o projeto poderia medir

Indicador	Como medir	Objetivo
Usuários cadastrados	Número mensal	Alcance
Buscas por hemocentro	Quantidade de pesquisas	Interesse/localização
Cliques para contato oficial	Quantidade	Conversão para serviço
Agendamentos iniciados/concluídos	Quantidade e taxa	Facilitação
Participação em campanhas	Número de usuários	Engajamento
Retorno para nova doação	Percentual	Fidelização
Satisfação do usuário	Pesquisa pós-uso	Qualidade da experiência

10. Conclusão

Os dados reunidos oferecem uma base quantitativa para justificar o estudo do Sangue Solidário. O Brasil possui uma ampla rede de serviços de hemoterapia e realiza milhões de coletas, mas a participação relativa da população ainda é baixa. Paralelamente, estudos brasileiros identificam barreiras de informação, localização, deslocamento, tempo e medo.

O dado de 81,7% de intenção de doar entre não doadores de um estudo de 2025 é particularmente relevante: ele mostra que a ausência de doação nem sempre representa ausência de interesse. Em determinadas populações, há pessoas que desejam doar, mas encontram obstáculos. O projeto pode investigar se uma experiência digital mais organizada consegue reduzir esses obstáculos.

Portanto, a justificativa acadêmica do Sangue Solidário está em um problema mensurável: facilitar a conexão entre cidadãos interessados e os serviços de hemoterapia, complementando as estruturas já existentes. A proposta deverá ser validada por testes com usuários e indicadores de uso.

11. Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Dados de doação de sangue e campanha nacional. 2025–2026. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/>. Acesso em: 30 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Relatório de Gestão Integrado 2025. Dados de remanejamento de hemocomponentes. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/>. Acesso em: 30 set. 2026.

ANVISA. Divulgado o 10º boletim sobre serviços de hemoterapia. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/divulgado-o-10-boletim-sobre-servicos-de-hemoterapia>. Acesso em: 30 set. 2026.

ANVISA. Dados brutos de produção hemoterápica. Atualizado em 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/sangue-tecidos-celulas-e-orgaos/producao-e-avaliacao-de-servicos-de-hemoterapia/dados-brutos-de-producao-hemoterapica>. Acesso em: 30 set. 2026.

ANVISA. Divulgado novo boletim de avaliação de serviços de hemoterapia. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/divulgado-novo-boletim-de-avaliacao-de-servicos-de-hemoterapia>. Acesso em: 30 set. 2026.

FEAR OF BLOOD, INJECTIONS AND FAINTING AS BARRIERS TO BLOOD DONATION IN BRAZIL. Vox Sanguinis. PubMed. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30485453/>. Acesso em: 30 set. 2026.

BARREIRAS E MOTIVAÇÕES PARA A DOAÇÃO DE SANGUE: revisão integrativa. Hematology, Transfusion and Cell Therapy. SciELO. 2024.

ESTUDO TRANSVERSAL SOBRE MOTIVAÇÕES, BARREIRAS E ESTRATÉGIAS PARA PROMOÇÃO DA DOAÇÃO DE SANGUE ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA. Hematology, Transfusion and Cell Therapy. 2025.

ARAÚJO, F. M. R. et al. Estudo sobre aceitabilidade e dificuldades de doadores em hemocentro público do Recife. Ciência & Saúde Coletiva.

APLICATIVO DE APOIO À DOAÇÃO DE SANGUE. Ciência & Saúde Coletiva. SciELO. Estudo sobre tecnologia e comunicação entre hemocentro, doador e cidadão.

Observação metodológica

Os percentuais de estudos científicos apresentados neste documento descrevem as amostras específicas de cada pesquisa. Eles não devem ser apresentados como se fossem percentuais de toda a população brasileira. Já os dados do Ministério da Saúde e da Anvisa são apresentados como indicadores nacionais ou administrativos conforme a fonte. Essa distinção aumenta a confiabilidade da apresentação acadêmica.